

إسم المريض رباعياً : هند محمود عبدالقادر سعيد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : السيده زينب
رقم البطاقة : 27810010100783 رقم التليفون : 01127719111
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 المهنة : ربه منزل
العنوان : 16 ش الشيخ - البغاله
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج: أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج:** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GR1-E
روسىستانى
لدى حساب
روسىستانى
صحة الامانات المرفعة
اللجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- /d ----- /d ----- /d.l ----- /d.l

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

--

Name: هند محمود عبدالقادر سعيد National ID: 27810010100783	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



طلب علاج أول مرة / متكرر

العنوان : البغاله

الحى / المدينة : السيد زينب

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 16-06-2026

رقم البطاقة : 27810010100783 رقم التليفون : 01129029833

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا أتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي- القوات المسلحة- الشرطة- الهيئات- المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف أتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإحصائي الاجتماعي

التوقيع: (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الاكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج : الاورام

خطة العلاج : علاج كيماوی تاکسول / کاربو

التعليق على التشخيص : -----



تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/ احمد نجيب

الاسم: د/ خالد عبدالعزيز

الاسم: د/ محمد الكيلاني

أطعت اللحنة على لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وَتَلْتَزِمُ جِهَةَ الْعِلَاجِ بِلَائِحَةِ الْمَجَالِسِ الطَّبِيبَةِ.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتبعيد المستشفى، أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د! ----- / د!

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى : --

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

مدیر عام

مديرية الشئون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

٢٤
٢٥
٢٥

٢٠٢٣/١١ ٢٧٨١٠٠١٠١٠٠٧٨٣
ربة منزل
أنثى مسلمة متروجة
حسين علي احمد مصطفى
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١١/١٥ ١



DMG
كياوي
م - ٢١

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
هند
محمود عبدالقادر سعيد
١٦ ش الشيخ - البقاله
السيدة زينب - القاهرة
١٩٧٨/١/١١ ٢٧٨١٠٠١٠١٠٠٧٨٣
KG5976032



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



06/07/2026

MDT FORM

Name: هبة محمود عبدالقادر سعيد	MRN: 9855
Age: 48 Y	ID: 27810010100783
Menopausal Sta	Phone:
NRS SCORE:	Marital Status:
BMI:	Family History:
CO Morbidity:	Reason Of MDT:

Clinical Data:

BX:

R

L

ER: lt 0/8 rt 8/8 PR: lt 0/8 rt m5/ HER2: lt -ve rt + KI67: lt 90% rt :

Sonomammography:

CESM : RT OUTER CENTRAL MIDDLE THIRD HETEROGENOUS MODERATE ENHANCING LOGTIJUDINAL LESION WITH INDISTINCT MARGINS 2.8*2.5*3.6 CM LOCATED 6.5CM FROM NIPPLE , LESION SURROUNDED BY FAINT ENHANCING FOCI OCCUPY MOST OF OUTER HALF OF BREAST WITH OVERALL COVERAGE AREA OF PROCESS 8.6*3.3*9.9CM \NON PATHOLOGICAL LN LT BREAST UPPER CENTRAL THIRD ROUND MODERATE HETEROGENOUS ENHANCING LESION WITH INDISTINCT 3.4*2.8*3.1CM LOCATED 3.5CM FROM NIPPLE \ LEVEL 1 TWO PATHOLOGICAL LN LARGEST 2.4*1.8CM

Mets Workup:

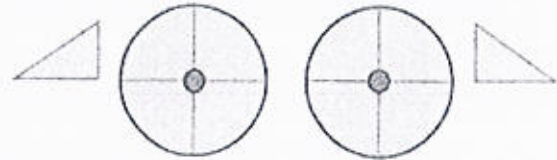
History:

Recommendations:

FOR NACT +CLIP INSERTION ON LT BREAST LESION
THEN RT SM+SLNB
LT WLE+ALND VS SLNB ACCORDING TO RESPONSE

MDT Outcome & Plan

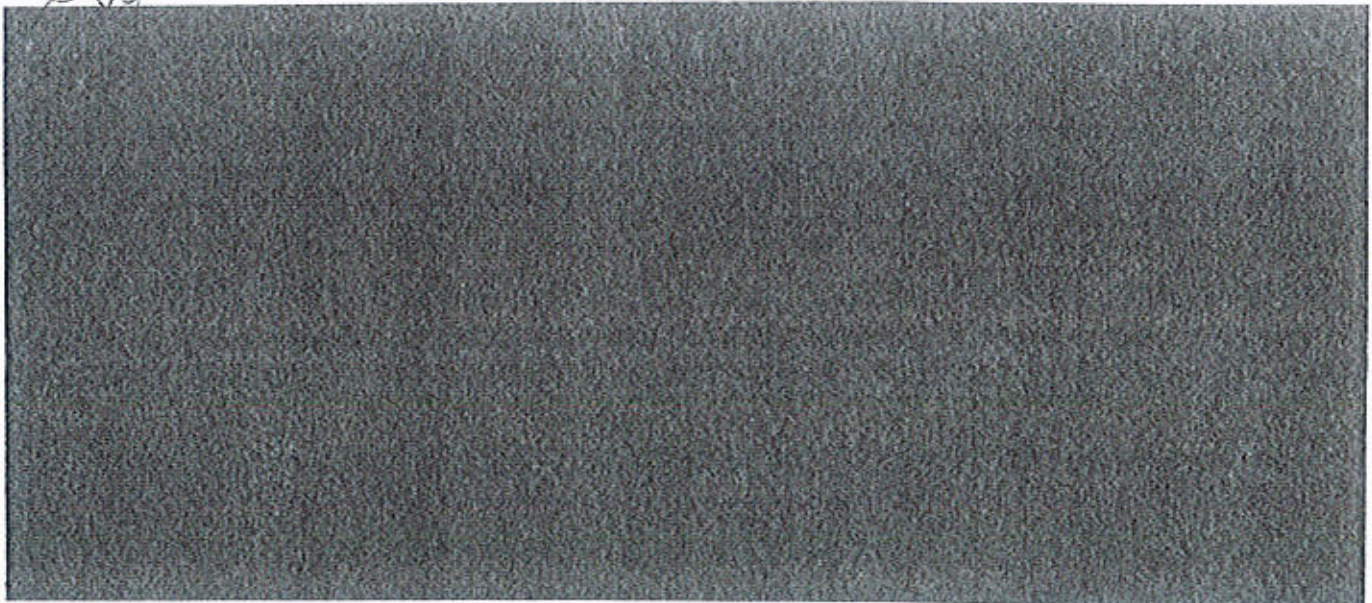
clips insertion BILAT
for neoadj taxol/carbo weekly followed by AC 4 cycles with keytruda 8 cycles
FOR CESM Post' neoadj



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ هاني عزت	د/ احمد لبيب				



Patient Name : الأستاذة / هند محمود عبد القادر سعيد

Patient No. : 27810010100783

Path No. : 717/26

Sex : Female

Age : 47 Y

Referring Doc :

Request No. : 13005463

Request Date : 15/03/2026

Verification Date : 23/03/2026

Financial Category : جوستاف روسي - مبادره

Department : Out Patient

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast (BIRADs 4c) suspicious lesion & Left breast (BIRADs 5) suspicious lesion with pathological axillary lymph node.

Nature of Specimen:

1- Right breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026, at 9:30 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

2- Left breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026, at 9:46 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

Two specimens were received as follow:

1- Right: Fragmented grey white tissue core, measured 1 cm long. Totally submitted.

2- Left: Four fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm. Totally submitted.

Microscopic Examination:

1- Right breast mass:

* Histological type: Invasive duct carcinoma.

* Grade 1 (differentiation 1, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).

* Ductal carcinoma in situ: Absent.

* Angioinvasion: Absent.

* Perineural invasion: Absent.

* Microcalcification: Absent.

2- Left breast mass:

* Histological type: Invasive duct carcinoma.

* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).

* Ductal carcinoma in situ: Absent.

* Angioinvasion: Present.

* Perineural invasion: Absent.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 13/06/2026 09:59:56

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No. : 13005463
Patient No. : 27810010100783	Request Date : 15/03/2026
Path No. : 717/26	Verification Date : 23/03/2026
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Age : 47 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

* Microcalcification : Absent.

Diagnosis:

- 1- Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 1.
- 2- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.
- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 13/06/2026 09:59:56

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / هند محمود عبد القادر سعيد
Patient No. : 27810010100783
Path No. : 717/26
Sex : Female
Age : 47 Y
Referreing Doc. :

Request No. : 13005463
Request Date : 15/03/2026
Verification Date : 23/03/2026
Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast (BIRADs 4c) suspicious lesion diagnosed invasive duct carcinoma, Grade 1 & Left breast mass (BIRADs 5) diagnosed invasive duct carcinoma, Grade 3.

Nature of Specimen:

- 1- Right breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026 at 9:30 am, Cold ischemia time: 20 seconds.
- 2- Left breast lesion, Tru-cut biopsy, collected on 15/03/2026 9:46 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin blocks (1 & 2), processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

1- Right breast mass:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 10%.

2- Left breast mass:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in 8% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 90%.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 13/06/2026 10:00:01

Page 1 of 3

Printed By : .marwa mohamed yousse



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	الأستاذة / هند محمود عبد القادر سعيد	Request No.	13005463
Patient No.	27810010100783	Request Date	15/03/2026
Path No.	717/26	Verification Date	23/03/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	47 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Diagnosis:

1- Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 1.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

- PR: Positive (score 5/8).

- Her2: Low (Score 1+) .

- Ki67%: 10%.

2- Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma , Grade 3.

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).

- PR: Negative (score 0/8).

- Her2: Ultra-low, (score 0+).

- Ki67%: 90%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 13/06/2026 10:00:01

Page 2 of 3

Printed By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient ID: 95189	Patient Name English: Hend Mahmoud Abdalkader
Age: 48 years old	20260505 11:49:21 AM :Report Date

Amoo

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: A case of bilateral IDC , Grade I on the right side & Grade III on the left side.

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: C(Heterogeneously dense)

History of bilateral breast reduction surgery.

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:**
 1. outer central middle third indistinct area of distortion.
 2. Inner central posterior third oval circumscribed isodense lesion measures 0.7x0.3cm located 13cm from the nipple .(based on CC view)
 3. Scattered benign calcifications.
- **Recombined (Post contrast) images:**
- outer central middle third heterogenous moderate enhancing longitudinal lesion with indistinct margins measures 2.8x2.5x3.6cm located 6.5cm from the nipple(index lesion), the lesion is seen surrounded by faint enhancing foci extend anterior , posterior , superior and inferior to the index lesion (occupy most of the outer half of the breast). With overall coverage area of the process 8.6x3.3x9.9cm with the nearest focus located 3cm from the nipple .
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:**
 1. 8:00 middle third irregular hypoechoic mass with distortion(index lesion).
 2. 7:00 zone C irregular hypoechoic lesion
 3. The other enhancing foci could not be detected accurately by US
 4. 3:00 probably benign non enhancing lesion
 5. Non pathological axillary lymph nodes.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** upper central middle third indistinct area of focal asymmetry.
- **Recombined (Post contrast) images :**upper central middle third nearly round moderate heterogeneously enhancing lesion with indistinct margins measures 3.4x2.8x3.1cm located 3.5cm from the nipple.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**
 1. 11-12:00 irregular hypoechoic lesion(index lesion)
 2. Level I discrete 2 pathologically enlarged lymphnodes the largest shows enlarged non uniform cortical thickness with indenting hilum, it measures 2.4x1.8cm with cortical thickness up 1.5cm

Patient Name الأستاذة / هند محمود عبد القادر سعيد
Patient No. 27810010100783
Path No. 717/26
Sex Female
Age 47 Y
Referring Doc.

Request No. 13005463
Request Date 15/03/2026
Verification Date 23/03/2026
Financial Category جوستاف روسي - مبادره
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 13/06/2026 10:00:01

Page 3 of 3

Printed By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

IMPRESSION:

RIGHT BREAST:

1. (BIRADS6 = pathologically proved malignancy): outer central & outer half pathological enhancing process as described roughly extend from (7:00-10:00) as described
2. (BIRADS3= probably benign lesion) 3:00 probably benign non enhancing lesion

LEFT BREAST: (BIRADS 6= pathologically proved malignancy): upper central unifocal enhancing mass as described .

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy. MD, FRCR,

اسم الفرع السيد زينة
مدير الفرع د. زينة ثقب
مدير الوحدة ا.د. رانيا درويش
طبيب الوحدة ا.د. علاء الدش

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
مختبر الامانة كاميل



رئيس مجلس الادارة
ا.د. مؤمنة كامل

مدير
ا.د. نبي

PATIENT NAME هنا محمود عبد القادر			Registered 24-05-2026 15:18:41	Collected 24-05-2026 15:18:43
Visit Number 20926506801	Age 48 Year	Gender Female	Authenticated 15-06-2026 10:19:40	Printed 21-06-2026 12:48:43
Referred By Prof : -			Client ID 55452	

MOLECULAR BIOLOGY REPORT Report

BRCA 1.2 WHOLE GENE SEQUANCING / BLOOD (Astrazneca)

Result : No Pathogenic variants detected in *BRCA1* or *BRCA2* genes sequencing.

Background

- Hereditary Breast Cancer accounts for about 5-10% of female breast cancer and 4-40% of male breast cancer. The most common cause is mutations in the *BRCA1* & *BRCA2* genes which are tumor suppressor genes located on chromosomes 17 and 13 respectively.
- Pathogenic variants of these genes are inherited in an autosomal dominant manner and are associated with hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) syndrome.
- HBOC syndrome increases the risk for breast (female and male), ovarian, fallopian tube, peritoneal, pancreatic, and prostate cancers. Additionally, *BRCA2* carriers may be at increased risk for melanoma.

Method

- Genomic DNA was extracted from the patient's specimen. Libraries were prepared according to manufacturer's protocol then next-generation sequencing was performed on the Illumina MiSeq platform using CE-IVD BRACA assay
- The assay analyzes sequencing of all exons and immediately adjacent intronic regions of *BRCA1* & *BRCA2* genes.
- Raw sequence data analysis, including base calling, demultiplexing, alignment to the hg19 human reference genome (Genome Reference Consortium GRCh37), and variant calling is done using standalone software. Variants are interpreted using publicly available databases such as Exac, GnomAD, dbSNP, ClinVar, Brca exchange. Variants are classified according to the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) guidelines.
- Benign and likely benign variants are not included in this report.
- Variants of unknown significance classification may change over time.

Limitations

- Large rearrangements may not be detected, variants in regions with high GC content or pseudogenes may give false negative or false positive results.
- The test result is for clinical reference and clinicians should interpret it in the context of the patient's condition, clinical

Rania Darwish

Dr. Rania Darwish
Prof of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

1-2

اسم الفرع السيد زينة
مدير الفرع د. زينة ثقب
مدير الوحدة ا.د. رانيا درويش
طبيب الوحدة ا.د. عتياء الش



س مجلس الإدارة
.. مؤمنه كامل

بر اله
د. هن

PATIENT NAME هن محمود عبد القادر			Registered 24-05-2026 15:18:41		Collected 24-05-2026 15:19:15
Visit Number 20926506801	Age 48 Year	Gender Female	Authenticated 15-06-2026 10:19:40		Printed 21-06-2026 12:48:43
			Referred By Prof. -	Client ID 55452	

findings, family history, other lab investigations, and international guidelines for treatment.

References

- Yoshida, Reiko. "Hereditary breast and ovarian cancer (HBOC): Review of its molecular characteristics, screening, treatment, and prognosis." Breast Cancer 28.6 (2021): 1167-1180.
- Richards, Sue, et al. "Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology." Genetics in Medicine 17.5 (2015): 405-423.

Rania Darwish.

Dr. Rania Darwish
Prof of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

2-2